한·중·일·대만 전통의학 vs 서양의학 의료비용 비교 분석

Oct 26, 2026 · @김재효

핵심 요약

전통의학이 전체 의료비에서 차지하는 비중은 중국 약 8%(추정) · 한국 4.6% · 대만 약 4.0% · 일본 1% 미만 순입니다. 한국과 대만은 치과·약국을 뺀 공적 보험 기준에서 4% 안팎으로 구조가 매우 유사하며, 일본은 독립 면허 체계가 없어 사실상 의과에 흡수되어 있습니다.

구분	한국	중국	일본	대만
기준 연도	**2023 (확정) / 2024 (잠정)**	2024	2023 회계연도	2024~2027
전통의학 제도	한의사 독립 면허 · 한의원/한방병원	중의사 독립 면허 · 중의병원 6,397곳	독립 면허 없음, 의사가 한방제제 처방	중의사 독립 면허 · 중의 진료소 중심
공적보험 내 비중	**4.11% (2023) → 4.56% (2024)** *(건보 급여, 치과·약국 제외)*	공식 금액 통계 미공개	침·뜸 요양비 0.10% (국민의료비) *(치과·약국 제외 시 0.14%)*	4.0% (건보 총액, 치과·기타 제외) 3.7% (건보 전체 총액 기준)
비급여·자부담 포함 비중	**4.64% (2023년 4.73조/101.9조)** *(참고: 2024년 비급여 보고자료상 전체 비급여 진료비 중 한의 비중 16.6%, 월 기준)*	약 7.9% (중의류 병원 수입 추정 ÷ 위생총비용)	0.7% 이하 (침구 요양비 + 한방제제 생산액, 상한)	2.8% (NHE 내 중의 진료소 + 자가 구입 중약)
진료량 비중	**10.4% (2023) → 11.0% (2024)** *(청구건수 9,273만건 → 9,757만건)*	16.6% (진료인차 16.8억 회)	미공개 (의료용 한방 연 17억 일분)	미공개
추세	총의료비 기준 2021년 5.17% → 2023년 4.64% 하락 *(급여 기준은 2023년 4.11% → 2024년 4.56% 상승. 상급종합병원 진료비 감소에 따른 분모 효과 포함)*	진료인차 2022→2024년 +36% 급증	침구 요양비 소폭 증가 (2019 441억 엔 → 2023 493억 엔)	건보 비중 3.7%로 고정, NHE 내 중의 진료소 비중 2.9%(2014) → 2.4%(2024) 하락

- **중국**은 중의가 병원급 전달체계를 갖춘 유일한 나라로, 규모는 크지만 중의병원 수입의 대부분이 양방 검사·약품에서 나옵니다(3급 공립 중의병원 외래 수입 중 중의 의료서비스는 8.6%).
- **대만**은 '중의 총액'을 따로 협상하는 구조라 비중이 매년 4.0% 수준으로 정확히 유지되며, 한국의 건보 급여 기준 비중과 가장 닮았습니다.
- **일본**은 한방이 의과 안에서 의사 처방(의료용 한방제제)으로 쓰여 '한의 vs 양방' 구분 통계 자체가 성립하지 않고, 별도로 잡히는 침·뜸은 의료비의 0.1%입니다.

- **한국**은 독립 면허를 가진 3개국 가운데 진료량 대비 비용 비중이 낮고(10.4% vs 4.6%), 비급여 의존도가 대만과 비슷하게 높습니다. 2024년에는 한의약 급여 비중이 4.56%로 올랐는데, 한의원 진료비 증가(+12.7%)와 함께 전공의 사직에 따른 상급종합병원 진료비 감소(-9.8%)가 분모를 줄인 효과가 섞여 있습니다.

분석 틀과 비교 시 주의점

본 보고서는 전통의학 vs 서양의학, 공적 보험 vs 자부담, 점유율 추이의 비교 틀을 적용했지만, 4개국 통계는 분모와 범위가 달라 같은 숫자로 바로 비교할 수 없습니다.

- **분모**: 한국은 치과·약국을 뺀 건보 심사실적입니다. 대만은 같은 기준을 맞추려고 건보 총액에서 치과·기타 예산을 뺀 값을 함께 제시했습니다. 일본 국민의료비는 치과·조제약국을 포함하며, 중국 위생총비용은 공중보건·자본지출까지 포함합니다.
- **중국 금액은 추정치**입니다. 중의류 병원의 진료인차 8.43억 회 × 병원 평균 외래비 361위안, 퇴원 4,225.7만 명 × 평균 입원비 9,870위안으로 약 7,200억 위안을 계산했습니다. 중의 진료소(3.1억 회)와 서양의 병원 내 중의과(5.3억 회)는 빠졌고, 중의병원의 1회당 비용이 평균보다 낮다면 과대 추정입니다.
- **일본 한방제제는 생산액**(2024년 2,663억 엔, 일반용 포함)이라 의료비와 성격이 다릅니다. 2023 회계연도 국민의료비에 2024년 생산액을 더해 계산한 표의 0.7%(493억 + 2,663억 엔 ÷ 48조 915억 엔)는 상한으로만 보십시오.
- **유도정복(柔道整復) 요양비**(2023년 2,759억 엔)는 접골 시술로 전통의학 범주가 아니어서 본문 비중에서 뺐습니다.
- 환율은 2024년 평균 근사치(1위안≈189원, 1엔≈9원, 1대만달러≈42.5원)이며, 비교는 금액보다 비중 위주로 했습니다.

중국: 진료량 6분의 1, 비용은 약 8%(추정)

2024년 중의류 의료기관 진료인차는 16.8억 회로 전체 101.5억 회의 16.6%이며, 중의류 병원 수입은 위생총비용 9.09조 위안의 약 7.9%로 추정됩니다.

지표	2022	2023	2024
중의류 진료인차 (억 회)	12.3	15.4	16.8
전체 대비 진료량 비중	14.6%	16.1%	16.6%
중의류 의료기관 수 (곳)	80,319	92,531	103,704
중의류 병상 (만 개)	158.7	173.2	182.3 (전체의 17.7%)

- **전달체계**: 2024년 진료인차의 50.1%가 중의류 병원, 18.2%가 중의 진료소, 31.7%가 서양의 기관 내 중의과에서 발생했습니다. 한국(한의원 80%)과 정반대로 병원 중심입니다.
- **비용 추정**: 중의류 병원 외래 약 3,040억 위안 + 입원 약 4,170억 위안 ≈ 7,200억 위안(약 136조 원)입니다. 위생총비용 대비 약 7.9%로, 진료량 비중(16.6%)의 절반 수준입니다.
- **'중의병원 ≠ 중의 서비스'**: 2023년 3급 공립 중의병원에서 중의 의료서비스 항목 수입은 외래 수입의 8.61%, 입원 수입의 13.22%에 그쳤습니다. 다만 약품 수입 중 중약은 56.52%(음편 38.11%)로, 탕약 비중이 커지는 추세입니다.
- **재원**: 2024년 위생총비용 중 개인 부담은 27.5%로 한국 의과와 비슷하지만, 중의 진료는 대부분 기본의료보험 급여 대상이라 한국 첩약처럼 비급여로 빠지는 구조가 아닙니다.

일본: 한방은 의과 안으로, 침·뜸은 0.1%

2023 회계연도 국민의료비 48조 915억 엔 가운데 침·뜸(はり・きゅう) 요양비는 493억 엔(0.10%)입니다. 치과·조제약국을 뺀 한국식 분모(36조 3,407억 엔)로 바꿔도 0.14%입니다.

항목 (억 엔)	2019	2020	2021	2022	2023
국민의료비	443,895	429,665	450,359	466,967	480,915
침·뜸 요양비	441	419	447	453	493
안마·마사지 요양비	757	636	660	668	752
(참고) 유도정복 요양비	3,213	2,863	2,905	2,791	2,759

- **한방은 '의사의 약'**: 일본에는 한의사 면허가 없고, 의사가 의료용 한방 엑스제제를 처방합니다. 그래서 한방 비용은 의과 진료비·조제약국 비용 안에 섞여 따로 집계되지 않습니다.
- **한방제제 규모**: 생약 등을 포함한 '한방제제 등' 생산액은 2015년 1,671억 엔에서 2023년 2,539억 엔으로 늘었고, 한방제제만 보면 2024년 2,663억 엔입니다. 의료용 한방제제는 의료용 의약품 생산의 약 2.25%이며, 연간 약 17억 일분이 처방됩니다.
- **침·뜸은 '요양비' 상환 방식**: 의사 동의서가 있어야 보험이 적용되고, 환자가 먼저 전액을 낸 뒤 돌려받는 구조여서 이용이 제한적입니다. 2024년 개정으로 방문시술료가 신설되는 등 재택 고령자 중심으로 재편 중입니다.
- 일본은 '전통의학의 의과 통합' 모델의 극단으로, 한국에 이원 체계 비교 대상보다는 첩약·한약제제 급여화 경로의 참고 사례에 가깝습니다.

일본 한방 의약품 vs 양방 의약품 규모

2024년 일본 의약품 국내 생산액 10조 2,485억 엔 가운데 한방제제는 2,663억 엔(2.60%)으로, 양방 의약품이 한방의 약 37.5배입니다. 의사가 처방하는 의료용만 보면 한방 엑스제제 등은 2,093억 엔(2.25%)이고 양방은 그 43.5배입니다.

구분 (2024년 생산액)	한방제제	양방 의약품	한방 비중	양방/한방 배율
전체	2,663억 엔	9조 9,822억 엔	2.60%	37.5배
의료용 (처방약)	2,093억 엔	9조 1,061억 엔	2.25%	43.5배
요지도·일반용 (OTC)	569억 엔	8,762억 엔	6.10%	15.4배

- **수입을 넣으면 비중은 더 작다**: 생산액에는 수입 의약품(2024년 4조 2,567억 엔, 거의 전부 양방)이 빠져 있습니다. 공급 전체로 보면 한방은 약 1.8%입니다.
- **소비 측면도 약 2%**: 2023 회계연도 약제비는 10.51조 엔(국민의료비의 21.9%)이고, IQVIA 기준 2024 회계연도 의료용 의약품 시장은 약가 기준 11조 4,874억 엔입니다. 의료용 한방 생산액 약 2,100억 엔을 대입하면 약제비의 약 2%로, 앞의 생산 비중과 같은 수준입니다.
- **양은 많고 값은 싸다**: 의료용 한방제제는 연간 약 17억 일분, 국민 1인당 약 14일분이 처방됩니다. 금액 비중이 2% 남짓인 것은 약가가 낮기 때문이며, 2024년 기준 의료용 한방 580품목 중 501품목(86.4%)이 원가 대비 '불채산' 품목으로 보고됐습니다. 원료 생약의 약 80%를 중국에서 수입하는 데 따른 가격 상승이 주원인입니다.
- **최근 성장은 한방이 빠르다**: 2024년 한방제제 생산은 전년 대비 12.8% 늘어 전체 의약품(+2.1%)의 6배 속도였습니다. 시장 점유율 약 80%인 쓰무라의 국내 의료용 한방 매출도 2024 회계연도 1,541억 엔으로 21.9% 늘었는데, 불채산품 약가 재산정에 따른 가격 인상 효과가 큽니다.
- **한국에의 함의**: 일본은 한방을 '의과 처방약'으로 급여해 연 17억 일분이라는 이용량을 만들었지만, 금액으로는 의약품의 2%대에 머뭅니다. 첩약·한약제제 급여 확대가 이용량은 크게 늘려도 의료비 비중을 크게 바꾸지는 않을 수 있다는 점을 보여 줍니다.

한국 한방 의약품 vs 양방 의약품 규모

건강보험 급여 약품비 기준으로 한국의 양방 의약품은 한방 의약품의 약 626~~669배로, 일본 의료용(43.5배)보다 격차가 14~~15배 큽니다. 다만 비급여 첩약·한약제제까지 넣으면 격차는 약 23배로 줄어, 일본(의료용 43.5배, 전체 37.5배)보다 오히려 작아집니다.

(2024년 한방 약품비 441억 원·0.16%는 언론 보도로 교차 확인했습니다. 2023년 391억 원은 KOSIS·심평원 통계표 `DT_354004N_022` 값이며, 양방 약품비는 건보공단 약품비 총액에서 한방 약품비를 뺀 값입니다.)

구분	한방 의약품	양방 의약품	한방 비중	양방/한방 배율
한국 건보 급여 약품비 (2022)	**369억 원**	22조 7,631억 원	**0.16%**	약 617배
한국 건보 급여 약품비 (2023)	**391억 원**	26조 1,575억 원	**0.15%**	약 669배
한국 건보 급여 약품비 (2024)	**441억 원**	27조 6,184억 원	**0.16%**	약 626배
한국 급여 + 한약 비급여 (2023, 추정)	**약 1조 1,200억 원**	약 26조 1,575억 원	**약 4.1%**	**약 23.4배**
(참고) 일본 의료용 생산액 (2024)	2,093억 엔	9조 1,061억 엔	2.25%	43.5배

- **급여 약품비의 극단적 격차(626배)**: 2024년 건강보험 총 약품비 27조 6,625억 원 중 한약제제 청구 금액은 **441억 원**(점유율 0.16%)에 불과합니다. 2022년 369억 원, 2023년 391억 원, 2024년 441억 원으로 전년 대비 증가세(+12.8%)는 뚜렷하지만, 급여 대상이 단미엑스산제 및 56종 혼합제제에 묶여 있어 양방 약품비(27.6조 원)와의 절대적 격차는 여전히 600배 이상입니다.
- **비급여 포함 시 격차 대폭 축소(약 23배)**: 2023년 한의약 전체 비급여 진료비(실태조사 역산 추정치 1조 2,780억 원) 중 첩약(76.7%, 약 9,800억 원)과 기타 제제(8.1%, 약 1,000억 원)를 더하면 비급여 한약 시장은 약 1조 800억 원에 달합니다. 여기에 급여 약품비(391억 원)를 합산한 **한약 의약품 총 소비액은 약 1조 1,200억 원**으로, 전체 양방 약품비 대비 약 4.1%를 차지하며 배율은 **23.4배 수준으로 대폭 축소**됩니다.
- **일본과의 구조적 차이**: 일본은 한방을 보험 처방약으로 넣어 '**급여 안의 2%**'를 실현했고, 한국은 한약의 대부분이 제도 밖 비급여에 머물러 있어 '**급여 안의 0.16%, 비급여 포함 시 4.1%**'입니다. 한국 국민이 한약에 지출하는 총비용은 일본 못지않으나, 그 약 96%가 비급여로 환자가 전액 부담하는 몫입니다.
- **비교 기준 주의**: 한방 약품비는 심평원 청구 기준, 양방 약품비 총액은 건보공단 지출 기준이라 집계 기준이 조금 다릅니다. 심평원 청구 총액(2024년 26조 9,897억 원)으로 나눠도 한방 비중은 0.16%로 같습니다.
- **2024년 제도 변화**: 2024년 4월 29일부터 '첩약 건강보험 적용 2단계 시범사업'이 시행되어 대상 질환이 기존 3개(안면신경마비, 뇌혈관질환 후유증, 월경통)에서 6개(요추추간판탈출증, 기능성 소화불량, 알레르기비염 추가)로 늘고, 참여기관도 한의원·한방병원에 더해 한방 진료과가 있는 병원·종합병원까지 넓어졌습니다. 본인부담률은 한의원 30%, 한방병원·병원 40%, 종합병원 50%이며, 환자 1인당 연간 2개 질환, 질환별 20일까지 적용됩니다. 이에 따라 2024년 이후 첩약의 제도권 급여 편입에 따른 통계적 이동이 점진적으로 나타날 전망입니다.

대만: 별도 '중의 총액'으로 4.0% 고정

대만 전민건보는 진료 부문별 예산 상한(총액)을 매년 협상하며, 중의문진 총액은 2027년 384.64억 대만달러로 전체 1조 434.47억의 3.69%입니다. 치과·기타 예산을 빼 한국 기준에 맞추면 4.0%로, 한국의 급여 비중 4.11%와 거의 같습니다.

연도	전체 총액 (억 대만달러)	중의문진 총액	전체 대비	치과·기타 제외 기준
2027	10,434.47	384.64	3.69%	4.01%
2026	9,883.35	364.29	3.69%	4.01%
2022	8,095.62	296.91	3.67%	3.99%

- **총액제의 효과**: 중의 비중이 협상으로 정해져 5년간 0.02%p밖에 움직이지 않았습니다. 2026·2027년에는 모든 부문이 똑같이 상한 5.5% 성장을 받았습니다.
- **국민의료보건지출(NHE) 기준**: 2024년 NHE 1조 8,897억 대만달러 가운데 중의 진료소 지출은 316억으로 개인 의료서비스의 2.4%이며, 2014년 2.9%에서 꾸준히 내려왔습니다. 가정이 직접 산 중약 220억을 더하면 NHE의 2.8%입니다.
- **자부담 구조**: 중의 진료소 지출 316억 가운데 가정 부담은 82억(26%)으로, 서양의 진료소(19%)보다 높습니다. 한국 한의약의 비급여율 27%와 비슷한 수준입니다.
- 다만 NHE의 중의 진료소 항목에는 병원 내 중의과가 빠져 있어, 건보 총액 기준(4.0%)보다 낮게 잡힙니다.

구조 비교와 한국 한의약에의 시사점

전통의학의 의료비 비중을 가른 것은 수요보다 제도, 곧 병원급 전달체계와 보험 편입 방식이었습니다.

구분	한국	중국	일본	대만
제도 모델	이원 체계, 1차 외래 중심	이원 체계, 병원 중심	의과 통합 (단일 면허)	이원 체계, 진료소 중심
핵심 치료의 보험 편입	첩약 대부분 비급여 (시범사업 2단계) 한약제제 극소수 급여 (0.16%)	음편·중성약·중의 서비스 대부분 급여 (일부 품목·적응증 제한)	의료용 한방 엑스제제(148처방) 의과 처방으로 급여	과립 한약제제(과학중약) 급여
비중을 정하는 장치	행위별 수가 + 비급여 시장	병원 수입 구조 (양방 검사/약제 결합)	의사 처방 관행 (약가 산정 체계)	부문별 총액 협상 (사전 예산 배정)
의료비 점유율 (공적)	**4.11% (2023) → 4.56% (2024)**	미공개 (병원 수입 기준 약 8%)	**0.10%** (침구 요양비 기준)	**4.01%** (중의문진 총액 기준)
의료비 점유율 (총액)	**4.64%** (급여 + 비급여)	**약 7.9%** (위생총비용 대비)	**0.7% 이하** (침구 + 한방제제 생산액, 상한)	**2.8%** (NHE 기준)

1. **대만은 한국의 가장 가까운 거울**입니다. 공적 보험 기준에서 비중이 4.0% 대 4.1%로 거의 일치하고, 환자 자부담 비율(26% 대 27%)도 매우 유사합니다. 차이는 대만이 과립 한약제제를 급여하고 '부문별 총액'으로 4% 몫을 사전에 보장받는 반면, 한국은 행위별 수가 체계에서 첩약의 급여 진입이 늦어 총의료비 기준 비중이 2021년 5.17%에서 2023년 4.64%로 내려왔다는 점입니다.
2. **중국은 병원급 전달체계가 비중을 키운다**는 점을 보여 줍니다. 중의류 병원 병상이 182만 개(전체의 17.7%)에 달해 16.6%의 진료량을 소화합니다. 다만 중의병원 수입의 상당 부분이 양방 검사·수술·화학약품에서 창출되므로, 외형적 비중 확대가 곧 중의 고유 의료기술의 비중 확대를 뜻하지는 않습니다.
3. **일본은 한약제제 급여화의 명암**을 동시에 보여줍니다. 의사가 처방하는 의료용 한방제제가 급여되면서 연간 17억 일분이 처방되는 대중적 이용량을 확보했지만, 제제 약가가 낮고 전통의학 고유 직역이 부재하여 의료비 내 비중은 2%대에 머물러 있습니다.
4. **한국에의 시사점**:
   - **약제 급여화와 병원급 전달체계의 동시 혁신**: 대만의 '제제 급여화 및 총액 안정' 모델과 중국의 '병원급 인프라 구축' 모델의 장점을 흡수해야 합니다.
   - **비급여의 제도권 편입**: 2024년 4월 확대된 첩약 건강보험 2단계 시범사업을 본사업으로 안착시키고, 한방물리요법·약침술의 단계적 급여화를 검토해 높은 비급여율(한방병원 45.1%, 한의원 20.5%)을 낮출 필요가 있습니다.

- **2024년 의정 갈등의 교훈**: 상급종합병원 진료가 줄어든 해에 한의원 급여 진료비가 12.7%, 한방병원이 19.9% 늘어난 것은, 경증·만성 근골격계 환자의 1차 의료에서 한의약이 보완 역할을 할 수 있음을 시사합니다. 다만 급여 비중 상승(4.11% → 4.56%)의 일부는 분모 감소 효과이므로, 한 해 자료로 구조적 변화를 단정하기는 이릅니다.

출처

- **한국**:
  - 통계청 KOSIS 국가통계포털: 「건강보험통계 - 요양기관종별 진료비 심사실적 (DT_LEE_02, 2021~2024)」
  - 통계청 KOSIS / 건강보험심사평가원: 「급여의약품·치료재료청구현황 - 한약제제 전체 청구현황(건강보험) (DT_354004N_022, 2020~2025)」
  - 국민건강보험공단: 「2021~2023년도 건강보험환자 진료비 실태조사」 (요양기관 종별 보장률 및 비급여 본인부담률)
  - 보건복지부 / 건강보험심사평가원: 「2024년도 비급여 보고자료 분석 결과」 (2024.9월 보도자료)
  - 첨부 보고서: 「한의약 전체 vs 양방 전체 의료비용 급여 및 비급여 비교분석 보고서」
  - 2024년 한방 약품비 441억 원·비중 0.16% (팜뉴스, 2026.6.21)
  - 2022년 한방 약품비 369억 원·전체 약품비 22.8조 원 (한의신문, 2023.11.10)
  - 2024년 건보 약품비 27조 6,625억 원 (한의신문)
  - 2024 급여의약품 청구 현황 (건강보험심사평가원)
  - 첩약 건강보험 2단계 시범사업 (한경비즈니스, 2024.4.28)
- **중국**:
  - 2024년 위생건강사업발전 통계공보 (국가위생건강위원회, 2025.12)
  - 2023년 통계공보 (국가위생건강위원회)
  - 2023년도 3급 공립 중의병원 성과 모니터링 통보 (국가중의약관리국)
  - 2024 위생총비용 (신화사 통계)
- **일본**:
  - 令和5(2023)年度 国民医療費の概況 (후생노동성, 2025.09)
  - あはき療養費 令和8年度改定 기본방향 자료 (후생노동성)
  - 令和6年 薬事工業生産動態統計年報의 개요 (후생노동성)
  - 薬剤費等の年次推移 (중의협 자료)
  - 2024년도 의료용 의약품 시장 (IQVIA, 일간약업)
  - 쓰무라(Tsumura) 2025년 3월기 결산 자료
  - 한방제제 등 생산액 2015→2023년 (약사일보)
  - 의료용 한방 86% 불채산 (약사일보, 2024.8.20)

    - 의료용 한방 처방량 연 17억 일분 (약사일보)
    - 의료용 한방제제 비중 약 2.1% (약사일보)
- **대만**:
    - 113년 국민의료보건지출(NHE) (위생복리부)
    - 116년도 건보 총액 협상 결과 공고 (위생복리부)
    - 115년도 건보 총액 결정 통지 (위생복리부)
    - 111년도 건보 총액 핵정 (위생복리부)